

INDICADO POR: Dr. Alberto

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

LUIZ CARLOS MIRANDA

IDADE: 47 PESO: 96 ALTURA: 182 PROFISSÃO: Tec. Segurança

SINTOMAS: Sonolência / Boca seca / Concentração ↓.
acorda algumas x sem saber porque.

QUEIXAS: esposa (romco)

MEDICAMENTOS: Lorazepam - Exitalopram 10mg.

MÉDICO: Dr. Alberto -

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 6x

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (19:30)

HORA QUE DORME: 10:30 HORA QUE ACORDA: 4:15

COCHILO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N 2 / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ NFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: sim

MALLAMPATI: IV

IAH:

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: sinistral / direita

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(S) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

14/02/26 Avaliação

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: LUIZ CARLOS MIRANDA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 17-01-2026

Idade: 47 anos

Peso: 96 kg

Altura: 1,82 m

Médico Solicitante: DR ALBERTO JORGE REMESAR

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 17/01/2026 22:06 e finalizado às 18/01/2026 05:44.

A latência para início do sono foi de **2,0 min** e a latência para o sono REM de **113,5 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 420,5 min, com eficiência do sono de **92,6 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,8 %** de estágio N1, **51,4 %** de estágio N2, **20,8 %** de estágio N3 e **26,0 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 31,5 min. Ocorreram 54 despertares, sendo o índice de **7,1 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **3,9 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 30, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 30 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **4,3 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 7,7 e o IDR durante o sono NREM foi de 3,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 4,3 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 4,3 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 95%, a média de 95% e a mínima de 90%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 3,8 (nº/h), sendo que em REM foi de 7,1 (nº/h) e em NREM foi de 3,1 (nº/h). Permaneceu 0,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório normal (**4,3 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina mantida (**90%**);
3. Latência para o início do sono normal (**2,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (**113,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono preservada (**92,6 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (**7,1 nº/h**) (VN= até 15 nº/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (**1,8 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**51,4 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**20,8 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Aumento do percentual do estágio REM (**26,0 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;
12. O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **3,9 (nº/h)**;
13. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6 cmH2O.


Dr. José Maria Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: LUIZ CARLOS MIRANDA

Data do Exame: 17-01-2026

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUIZ CARLOS MIRANDA			
Sexo: M	Idade: 46 anos	Peso: 96 Kg	Altura: 1.82 m
IMC: 29.0	Data do Exame: 03/10/2025	Exame: 01019_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 11:43:18 PM horas e encerrado às 3:07:12 AM horas, com latência para o sono de 2 minutos e latência para o sono REM de 195 minutos. O tempo total de sono foi de 204.5 minutos, com eficiência do sono de 98.6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.0%	Até 5%
Estágio 2	87.8%	45 - 55%
Estágio 3	7.3%	> 15%
Sono REM	3.9%	20 - 25%
Eficiência do sono	98.6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 0.5 minutos ocorreram **100 despertares (índice de 29.3 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 69 bpm, a maior de 83 bpm e a menor de 60 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 192 eventos respiratórios, sendo 0 central e 192 obstrutivos. Sendo 190 apnéias, 2 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 56.3/hora**, sendo 55.8 apnéia/hora e 0.6 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 16.8 e a duração máxima de 36.5.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 75.0/hora, sendo 75.0 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **94%**, sendo a saturação **média de 89%**, a **maior de 96%** e a **mínima de 81%**, permanecendo 82.5 minutos (39.8%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 193 dessaturações. Índice de dessaturações: 53.4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 68.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 53.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR

Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Psiquiatria pela UFRJ

Mestre em Psiquiatria pela UFRJ

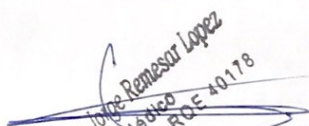
Doutor em Ciências pela UNIFESP

Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono

CRM 69.730 - RQE 40.178

Prezada Dra. Ana Claudia.
Solicito o aluguel ou venda do CPAP
para o Sr. Luiz Carlos Miranda para tra-
tar a síndrome da apnéia obstrutiva
do sono. Ele relatou que usou máscara
nasal. Pressão: 6 cm H₂O.
Diagn: G47.3

Att,


Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730 - RQE 40.178

5/9/13/12/26

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008